

עקרונות המודל החדש: סל תפקוד אישי AI

1. גישה מכוונת אדם :
 - סל שירותים גמיש ומותאם אישית לכל אזרח ותיק.
 - דגש על מניעה, שימור תפקוד ושיפור איכות חיים.
2. שימוש בטכנולוגיה ונתונים :
 - פלטפורמה דיגיטלית לניהול הסל האישי ומדידת תוצאות.
 - שימוש ב AI-להתאמה מיטבית של שירותים ולזיהוי מוקדם של הידרדרות.
3. שילוב כוחות קהילתיים :
 - הרחבת מעגל השירותים לכלול ארגונים קהילתיים, עמותות ומתנדבים.
 - חיזוק תחושת השייכות והמשמעות בחיי האזרחים הוותיקים.
4. מערכת תמריצים חדשה :
 - תמרוץ שירותים על בסיס תוצאות ומניעת הידרדרות.
 - עידוד חדשנות ויזמות בפיתוח שירותים חדשים.
5. שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-מגזרי :
 - יצירת מנגנון עבודה משותף ותיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
 - שילוב המגזר הפרטי והשלישי בפיתוח ואספקת שירותים.

מרכיבי סל התפקוד האישי

1. שירותי מניעה והעצמה :
 - תוכניות לשימור ושיפור תפקוד חברתי, פיזי וקוגניטיבי.
 - פעילויות לחיזוק קשרים חברתיים ותחושת משמעות.
2. שירותי תמיכה :
 - סיוע בפעולות יומיומיות.
 - תמיכה טכנולוגית (כגון לחצני מצוקה חכמים).
3. שירותי בריאות מונעת :
 - מעקב ומענה לקידום בריאות מותאם אישית.
 - תזונה ופעילות גופנית מותאמת.
4. שירותים קהילתיים :
 - חיבור לקהילה ולשירותים חברתיים.
 - תוכניות תעסוקה והתנדבות מותאמות.

מענה לאתגרים הקיימים

1. פתרון למשבר התקציבי :
 - הפחתת עלויות ארוכות טווח באמצעות מניעה ושימור תפקוד.
 - שימוש יעיל יותר במשאבים קיימים דרך התאמה אישית.
 - תמרוץ המערכת למניעה דרך מדידה ואלגוריתם היוצר תעדוף לשירות מונע.
2. התאמה למצבי חיים וצרכים משתנים :
 - גמישות בבחירת שירותים מתוך הסל האישי.
 - יכולת להתאים את הסל בזמן אמת לשינויים במצב וצרכי האזרח הוותיק.
3. פתרונות למשבר כוח האדם :
 - הפחתת העומס על מטפלים מקצועיים אישיים באמצעות תמרוץ שירותים קהילתיים ושילוב טכנולוגיה וכוחות קהילתיים.
 - יצירת מסלולי קריירה חדשים בתחום הסיעוד הקהילתי.
4. יצירת מדיניות אחודה :
 - הקמת גוף תיאום בין-משרדי לניהול הרפורמה.
 - פיתוח מערכת שיתוף מידע לכל הגורמים המעורבים.

- ניהול חכם ושינוי ושיפור שוטף ומתמיד על בסיס נתונים.
- 5. **קידום טכנולוגי :**
 - השקעה בפלטפורמה דיגיטלית מתקדמת לניהול הסל האישי.
 - עידוד פיתוח ואימוץ של טכנולוגיות חדשניות בתחום הסיעוד כמוצר תחליפי ומשלים לחוסר במטפלות.
- 6. **דגש על מניעה :**
 - תמריצים כלכליים למניעת הידרדרות ולשיפור תפקוד.
 - שילוב תוכניות מניעה והעצמה כחלק אינטגרלי מהסל.

יישום החלטות ממשלה ודו"ח קידר

יישום הרפורמה מבוסס על החלטות ממשלה 127 ו-150 לאימוץ מפת המדדים להזדקנות מיטבית דרך קידום שייכות ומשמעות, תפקוד ובריאות, חוסן כלכלי ואישי ודיגיטציה כתשתית תומכת ומסייעת.

סל השירותים המוצע מתבסס על החלטות ממשלה 127 ו-150, ומכוון לקידום הזדקנות מיטבית דרך ארבע מטרות ליבה:

1. שייכות ומשמעות
2. תפקוד ובריאות
3. חוסן כלכלי ואישי
4. דיגיטציה כתשתית תומכת ומסייעת

כהמשך לממצאי דו"ח קידר (הוועדה הבין-משרדית למניעת הידרדרות תפקודית) ולאימוץ המסקנות בחוק ההסדרים 2023, אנו פועלים יחד במסגרת הרפורמה ליישום הצעדים הבאים:

1. **פיתוח מערך שירותים מותאם אישית :** יצירת מנגנון גמיש המאפשר התאמה מדויקת של השירותים לצרכי כל אזרח ותיק, תוך התחשבות במצבו התפקודי, החברתי והכלכלי.
2. **הרחבת שירותי קהילה תומכת :** הפיכת שירותי קהילה התומכת לזמינים לכל זכאי גמלת סיעוד ברמות הנמוכות, כפי שהומלץ בדוח קידר.
3. **שילוב קופות החולים :** יצירת מנגנון תמרוץ לקופות החולים למניעת הידרדרות תפקודית, בדגש על אוכלוסיית הסיכון וזכאי הגמלה ברמות הנמוכות.
4. **פיתוח מדדי תוצאה :** יצירת מערכת מדידה והערכה המתמקדת בתוצאות ובאיכות החיים של האזרחים הוותיקים, ולא רק בתשומות ובתפוקות.
5. **חיזוק המערך הטכנולוגי :** השקעה בפיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות לניטור, מניעה וטיפול, כולל פלטפורמה דיגיטלית מרכזית לניהול הסל האישי.
6. **שיפור מעמד המטפלים :** יישום המלצות הצוות הייעודי לשיפור תנאי העבודה, ההכשרה והפיתוח המקצועי של המטפלים הסיעודיים.
7. **קידום מניעה ראשונית :** פיתוח תוכניות מניעה מקיפות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
8. **שיפור הסנכרון בין הגופים :** יצירת מנגנוני שיתוף מידע ותיאום בין כל הגורמים המעורבים במערכת הסיעוד, כולל משרדי הממשלה, קופות החולים, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר השלישי.

שותפויות ושיתופי פעולה

הרפורמה מבוססת על שיתוף פעולה הדוק בין גורמים רבים:

- המוסד לביטוח לאומי
- משרד הרווחה והביטחון החברתי
- משרד הבריאות
- קופות החולים
- רשויות מקומיות
- המשרד לשוויון חברתי
- משרד האוצר
- מערך הדיגיטל הלאומי
- ארגוני המגזר השלישי
- חברות טכנולוגיה וסיעוד
- ארגונים קהילתיים, עמותות ומתנ"סים
- המגזר היזמי והעסקי

תוכנית יישום - כ-3 שנים לשלב הראשון

1. **שלב הכנה (6 חודשים):**
 - המשך גיבוש ופיתוח בצוות בין-משרדי ליישום הרפורמה.
 - פיתוח ראשוני של הפלטפורמה הדיגיטלית.
 - גיבוש ובניית מסגרת רגולטורית תומכת.
 - הפעלת פיילוט ראשון בירושלים (500 משתתפים).
2. **פיילוט (שנה):**
 - הפעלה ב-5 רשויות מקומיות מייצגות.
 - איסוף נתונים ומשוב מכל השותפים.
3. **הערכה והתאמה (3 חודשים):**
 - ניתוח תוצאות הפיילוט.
 - התאמת המודל בהתאם ללקחים והכנה להרחבה.
4. **הרחבה הדרגתית (3 שנים):**
 - פריסה ארצית בשלבים.
 - הכשרה מתמשכת של כוח אדם.
 - המשך פיתוח והתאמה של הפלטפורמה הדיגיטלית.

כיווני מדידה והערכה

הצעת יעדי וכיווני מדידה והערכה בפיתוח צוות מדדים (בתוך צוות מדידה):

1. **איכות חיים:** פיתוח כלי מדידה להערכת איכות החיים של מקבלי השירות.
2. **תפקוד:** מעקב אחר שיעורי הידרדרות תפקודית בקרב האוכלוסייה המטופלת.
3. **חסכון תקציבי:** מעקב אחר השפעות השינוי על העלויות בסיעוד, בקופ"ח ובביטוחים.
4. **שביעות רצון:** סקרים תקופתיים של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם.
5. **יעילות מערכתית:** בחינת שיעורי אשפוז ומיסוד בקרב מקבלי השירות.
6. **חדשנות:** מעקב אחר אימוץ טכנולוגיות חדשות ופיתוח שירותים חדשניים.

א. מדדי תוצאה:

- שיעור הירידה בהידרדרות תפקודית (שנתי)
- שיעור הירידה באשפוזים חוזרים (רבעוני)
- שיפור במדדי איכות חיים (שנתי)
- שינוי ברמת העצמאות התפקודית (חצי שנתי)
- ירידה בצורך בטיפול סיעודי ארוך טווח (שנתי)

- ירידה בטיפול הפרטני ועלייה במענה הקבוצתי (שנתי)
- ירידה בבני משפחה מטפלים בשכר (שנתי)

ב. מדדי תהליך:

- שיעור השימוש בפלטפורמה הדיגיטלית וצריכת שירותים (חודשי)
- שיעור צריכת השירות מתוך יחידות סיעוד צבועות (חודשי)
- מספר התערבויות מניעתיות שבוצעו (מדידה חודשית)
- זמן תגובה ממוצע לאירועים חריגים (חודשי)
- היענות לתוכניות מניעה והתערבות מוקדמת (חודשי)

ג. מדדים כלכליים:

- חיסכון בהוצאות הסיעוד (שנתי)
- של התוכנית (שנתי)
- עלות ממוצעת לאזרח ותיק בתוכנית לעומת הטיפול המסורתי (שנתי)
- חיסכון במערכת הבריאות מירידה באשפוזים (שנתי)
- חיסכון בעלויות הטיפול והביטוח הסיעודי בקופ"ח

ד. מדדי השפעה חברתית :

- שינוי במעורבות וההשתתפות החברתית של אזרחים ותיקים (שנתי)
- השפעה על תעסוקת אזרחים ותיקים ובני משפחה מטפלים (שנתי)
- שינוי בתפיסה החברתית ועסקית כלפי האזרחים הותיקים (דו-שנתי)
- עמידות המערכת במצבי חירום (הערכות תקופתיות)

ה. מנגנון הערכה:

- הקמת ועדת מעקב בלתי תלויה
- דו"חות רבעוניים ושנתיים
- סקרי שביעות רצון של מטופלים ומשפחות (חצי שנתי)
- סקרי שביעות רצון של מטופלים ומשפחות (חצי שנתי)
- ביקורות עמיתים בינלאומיות (שנתי)
- פורום משתמשים לקבלת משוב (רבעוני)

ו. שימוש ב: Big Data:

- ניתוח מגמות ותבניות לזיהוי מוקדם של סיכונים
- התאמה אישית של תוכניות התערבות על בסיס נתונים
- פיתוח מודלים פרדיקטיביים לזיהוי אוכלוסיות בסיכון
- שילוב נתונים ממקורות חיצוניים

המלצות

1. בחינת גישת האדם במרכז ו"סל שירותים אישי" כשיטת עבודה של הממשלה מול האזרח ומדיניות לאומית.
2. מתן סמכות והכרה לצוות מניעה ב"פורום ברק" כצוות בין-משרדי ליישום הרפורמה.
3. הקצאת תקציב ייעודי לפיתוח הפלטפורמה הדיגיטלית ולהפעלת הפיילוט.
4. יצירת מסגרת רגולטורית גמישה להרחבת והתאמת סל השירותים למניעה תוך שילוב חדשנות בשירותי סיעוד.
5. פיתוח תוכנית הכשרה מקיפה לכוח האדם במערכת הסיעוד.
6. יצירת מנגנוני תמרוץ לדחיקת תלות ולשיתוף פעולה בין-מגזרי.

סיכום

המעבר לגישת "סל תפקוד אישי" מהווה הזדמנות ייחודית לשנות את פני מערכת הסיעוד בישראל. זוהי לא רק תוכנית להצלת המערכת מקריסה, אלא גם הזדמנות ליצירת מודל חדשני ואפקטיבי שיכול לשמש כמופת עולמי למענה חדשני וחכם לאתגרי הזדקנות האוכלוסייה בעולם המערבי.

רפורמה זו מדגישה את חשיבות הגישה המערכתית והטיפול הרב-מקצועי, תוך התמקדות במניעה וקידום בריאות. היא מחזקת את הקשר בין האזרח הוותיק לקהילה, מנגישה מידע ושירותים, ומעצימה את האזרח הוותיק להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות לטיפולו.

יישום מוצלח של הרפורמה יביא לשיפור משמעותי באיכות החיים של האזרחים הוותיקים בישראל, תוך יעול המערכת והפחתת העומס התקציבי בטווח הארוך. אנו קוראים למקבלי ההחלטות לאמץ גישה זו ולהוביל את השינוי הנדרש במערכת הסיעוד הישראלית.

בברכה,

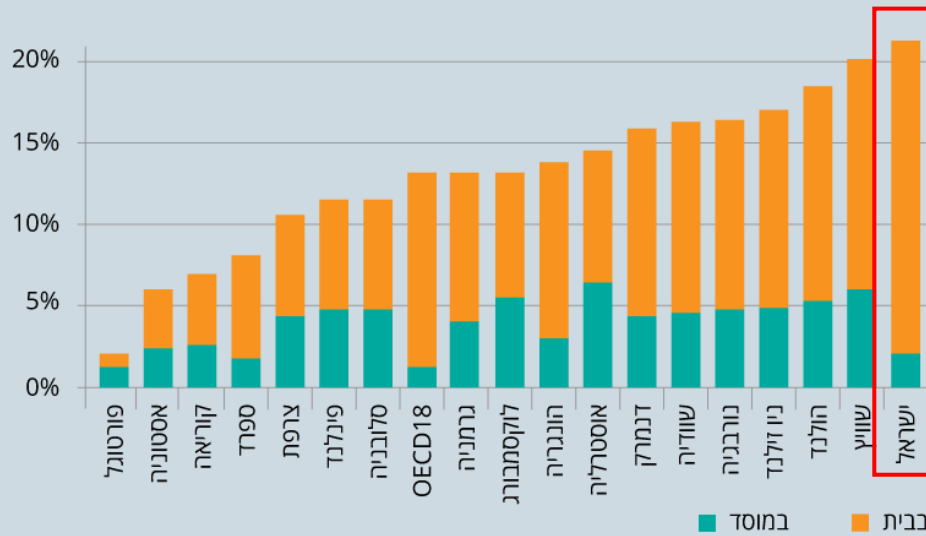
אביעד 'צחקי' - ראש אגף תכנון מדיניות הזדקנות האוכלוסייה, משרד הרווחה נטלי גבאי - ראש אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי ד"ר רויטל גרוס נבו - מנהלת המחלקה לשירותי קהילה, אגף גריאטריה, משרד הבריאות

נספחים

נספח א':

אחוז סיעודיים במדינות המערב 2017:

אחוז הקשישים הסיעודיים מתוך האוכלוסייה לפי מדינות



נספח ב:

צפי מקבלי חוק סיעוד בישראל:

נספח ג':

תיאור מקרה לדוגמא

הסיפור הסיעודי של יוסי כהן, בן 72 – דוגמת אמת

רקע

זכר, בן 72, פרוד, אב ל- 3 ילדים, גר לבד, בעל חברה להפקת אירועים, עדיין עובד כעצמאי, סובל מכמה מחלות. "כל מאמץ מקבל קושי בנשימה וסטורציה יורד, מונע ממני לתפקד כמו שצריך, מבקש עזרה במיוחד לניקיון הבית, החלפת מצעים וכביסה. בכסף יש לי משהו שעוזר לי. קם מישיבה ושכיבה תומך בכיסא או מיטה, הולך ללא שימוש באביזרים ביציבות. לא יכול ללכת יותר מ- 50 מטר בגלל מצב הריאות. נוסע עם אוטו שלי לעבודה. מתרחץ ומתלבש בעצמי ללא עזרה, מצב נפשי בסדר, דואג על מחלות וניתוחים שצריך לעשות, ישן טוב בלילות, עובד בישיבה במשרד, לפעמים עם חמצן לפעמים בלי, הבעיה שלי – לא יכול לטפל בבית כמו ניקיון, כביסה ובישול. שמיעה תקינה, עברתי ניתוח קטרקט"

טופס תביעה לגמלת סיעוד מיום 1.2.2024:

חי בנפרד לבד כבר 15 שנים. דובר עברית.

סיבה להגשת התביעה: "אושפזתי במשך שבוע עקב קשיי נשימה קשים עקב מחלת COPD, וכן אובחנה דלקת ריאות, אני מרותק לחמצן 24/7 ורמת החמצן יורדת בתוך דקות אם אני קם לביצוע עבודות בית או בדומה לזה, זקוק לעזרה בסידורים בבית ומחוץ בקניות וקופת חולים."

הכנסות:

אין הכנסות כעצמאי, יש הכנסה מחסכונות, לא מקבל תשלום או שירותים/עזרה משום גורם.

טופס "אירועים" ראשון (אפיינס):

תאריך החלטה: 18.2.2024

סוג החלטה: מחודש 02.2024 עד חודש 12.2899

מסלול ת. שרות: 20 רמה 1, בחירת כסף.

זמינות: תשלום: 1 לזקן, אישור תוספת ג. כסף. יח. מותרות 5.5

טופס "אירועים" שני (אפיינס):

תאריך החלטה: 19.2.2024

סוג החלטה: מחודש 03.2024 עד חודש 12.2899

מסלול ת. שרות: 22 רמה 1 – משולבת בשווי 5.5 / מופחת

בן משפחה מטפל: כ,ל

זמינות: תשלום: 6 לזקן+ ולנות"ש. אישור הוספת ג. כסף.

טופס "אירועים" שלישי (אפיינס):

ת. קובע 01.02.2024 מועד מחייב 07.04.2024

ת. עדכון 04.02.2024 הכנסה לשלושה חודשים: 8026

חודש 1: 11.2023. מקור הכנסה 2. סה"כ 2646

חודש 2: 12.2023. מקור הכנסה 2. סה"כ 2646

חודש 3: 01.2024 מקור הכנסה 2. סה"כ 2734

טופס הערכת תלות על יסוד מסמכים והשלמת מידע בטלפון

תפקוד	הערכה קודמת	ניקוד חדש	תפקוד	ניקוד קודם	ניקוד חדש
ניידות וסיכון גבוה לנפילות חוזרות	אין	1.0	סה"כ ניקוד ADL	אין	2.0
			ניקוד השגחה		
הלבשה		0.5	אופי המגבלה		קבוע
רחצה		0.5	מצב אקוטי חריף זמני		
אכילה		0.0	מצב רפואי קבוע		
הפרשות		0.0	בודד		כן

מסמכים שצורפו לתביעה ובמהלך הטיפול בהערכה (רלוונטים לביסוס החלטה):

- סיכום אשפוז.
- סיכום ביקור רופא ריאות.
- סיכום ביקור אורולוג.

סיבת הגשת התביעה:

אושפז עם דלקת ריאות, סובל מ- COPD (מחלת חסימה ריאתי כרוני), זקוק לחמצן ביום במאמץ ובכל הלילה, אובחן אנירוזמה של אאורטה הבטני, מועמד לניתוח. אובחן גוש בכליה הימנית ועליה ב- PSA, מועמד לטיפול אצל אורולוג.

סיכום הבעיות החריפות:

- סובל מ- COPD לפני 15 שנה בדרגה בינונית עד קשה. פנה למיון עקב דלקת ריאות והחמרה של COPD, טופל ומצבו השתפר. CT חזה איפזמה במיוחד באונה התחתית. יש היפוקסמיה שלא הייתה בעבר.

- זקוק לחמצן נייד בכל מאמץ 5 ליטר ובליה בשינה 2 ליטר. במנוחה מוחלטת אפשר ללא חמצן, טיפול בטלרגי כל יום, אטרובנט לפני מאמץ.
- יתר לחץ דם.
- אירוע מוחי לפני 3 שנים. מאז חולשה בצד ימין. מטופל תרופתית.
- אניורזמה באאורטה בטני. מועמד לניתוח.
- חשד לסרטן בכליה.

המלצות הגורמים המטפלים:

- לרכוש מכשיר אינהלציה.
- לעשות שיקום ריאות לפני ניתוח.
- לחזור על CT ריאות.

בחירת מסלול:

- ניתן להשלים את המידע בשיחת טלפון.
- לא מקבל גמלת סיעוד.
- אינו סובל מהפרעה קוגניטיבית או נפשית ואינו זקוק להשגחה.
- אותרו גורמי סיכון רפואיים פעילים המעמידים את הנבדק בסיכון גבוה לנפילות: אאורטה אניורזמה COPD אירוע מוחי.

ניקוד:

- ניידות: 18 – מתנייד בעצמו במאמץ – 1 נק'.
- הלבשה 36 – מתלבש בעצמו במאמץ – 0.5 נק'
- רחצה 46 – מתרחץ בעצמו במאמץ – 0.5 נק'
- אכילה 51 – עצמאי, אוכל ושותה, מחמם ומגיש ללא עזרה – 0 נק'
- שמירה על היגיינה וטיפול – עצמאי בטיפול ושמירה על היגיינה – 0 נק'
- איננו ערירי; יש לו תמיכה סביבתית; אין צורך לערב גורם מטפל;
- אישור תקופת זכאות בסיעוד מטעם בטל"א מיום 8 במאי 2024:

מחודש 02.2024 עד 04.2024

רמת זכאות: 1

תשלום למבוטח: 4,063

תשלום לנותן השירות: 37.99



יוסי כהן, בן 72

פרופיל וסל תפקוד אישי AI

רקע:

- גיל: 72
- מצב משפחתי: פרוד, אב ל-3 ילדים
- מקום מגורים: גר לבד
- תעסוקה: בעל חברה להפקת אירועים, עובד כעצמאי

מצב בריאות:

- COPD (מחלת חסימה ריאתי כרונית) בדרגה בינונית עד קשה
- דלקת ריאות
- יתר לחץ דם
- אירוע מוחי
- אניורזמה באאורטה בטנית
- חשד לסרטן בכליה
- קשיי נשימה, ירידה ברמת החמצן במאמץ
- חולשה בצד ימין
- מוגבלות בהליכה למרחקים קצרים
- עצמאי בפעולות יומיומיות (הלבשה, רחצה, אכילה)

בעיות תפקוד:

- קשיי נשימה חמורים, ירידה ברמת החמצן במאמץ, המחייבים שימוש בחמצן נייד ובלילה.
- חולשה בצד ימין כתוצאה מאירוע מוחי, המגבילה את תנועתו.
- קשיים בביצוע עבודות בית, כמו ניקיון, כביסה ובישול.
- חשש מפילות כתוצאה ממחלותיו ומצב גופו.
- בדידות חברתית עקב קשיי תפקוד.

מטרת סל השירותים:

לאפשר ליוסי ליהנות מחיים מלאים ומשמעותיים ולחזק את בריאותו הנפשית והפיזית, דרך:

- **עצמאות ותפקוד:** באמצעות טכנולוגיות מסייעות, שירותים קהילתיים והדרכה
- **מניעת הדרדרות:** באמצעות פעילות גופנית, אימון קוגניטיבי וניהול חיים בריאים.
- **שיפור איכות חיי:** באמצעות תמיכה רגשית, חברות ותחושת משמעות.
- **הבטחת ביטחון ורווחה:** באמצעות שירותי חירום ותמיכה סביבתית להפחתת תחושת הבדידות והתלות בבני משפחה.

עקרונות חשובים:

- סל השירותים המומלץ צריך להיות מותאם אישית לצרכיו הייחודיים של יוסי.
- רצוי שיוסי יהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לסל השירותים שיוענק לו.
- חשוב לעקוב אחר התקדמותו של יוסי ולעדכן את סל השירותים בהתאם לצורך.

סל שירותים מומלץ AI

שירותים קהילתיים:

- **קבוצות תמיכה לחולים ב: COPD-** להחלפת מידע, תמיכה רגשית וחברות.
- **מועדון חברתי ופרלמנט:** לפעילויות חברתיות, הרצאות והעשרה.
- **פעילויות גופניות מותאמות:** לשיפור הכושר הגופני והבריאות הכללית.
- **התנדבות:** לתחושת משמעות, שייכות ותרמה לקהילה.

הדרכה וכלים:

- **הדרכה לשימוש בטכנולוגיות מסייעות:** למיקסום יעילותן ונוחות השימוש.
- **אימון קוגניטיבי:** לשמירה על זיכרון ותפקודים קוגניטיביים.
- **טיפים ותזכורות לניהול חיים בריאים:** בנוגע לתזונה, פעילות גופנית וניהול תרופות.
- **סיוע בהתאמת סביבת המגורים:** להקטנת הסיכון לנפילות ולשיפור הנוחות.

תמיכה לעצמאות פיזית, תפקודית, רגשית וחברתית:

- **פיזיותרפיה:** שיפור כושר גופני, חיזוק שרירים, שיפור שיווי משקל והפחתת הסיכון לנפילות.
- **ריפוי בעיסוק:** הדרכה לביצוע פעולות יומיומיות באופן עצמאי ובטוח.
- **טיפול רגשי:** סיוע להתמודדות עם קשיים רגשיים, בדידות ודיכאון.
- **ליווי חברתי:** פעילויות חברתיות בקהילה, מפגשים עם חברים, קבוצות תמיכה.
- **הדרכה וייעוץ:** הדרכה לבני המשפחה בנוגע לטיפול נכון ביוסי, ייעוץ בנוגע לזכויותיו והטבות המגיעות לו.
- **שירותי חירום:** התקנת לחצן מצוקה, שירותי אבטחה, ליווי בהגשת תביעות לביטוח לאומי.

טכנולוגיות מסייעות:

- **מכשיר אינהלציה נייד:** לסיוע בנשימה קלה יותר במהלך היום.
- **רובוט שואב אבק:** לניקוי הבית באופן עצמאי.
- **מערכת בית חכם:** לשליטה בתאורה, טמפרטורה ואביזרים אחרים בבית בקלות.
- **טלפון חכם עם ממשק ידידותי:** לתקשורת, גישה למידע ובידור.

